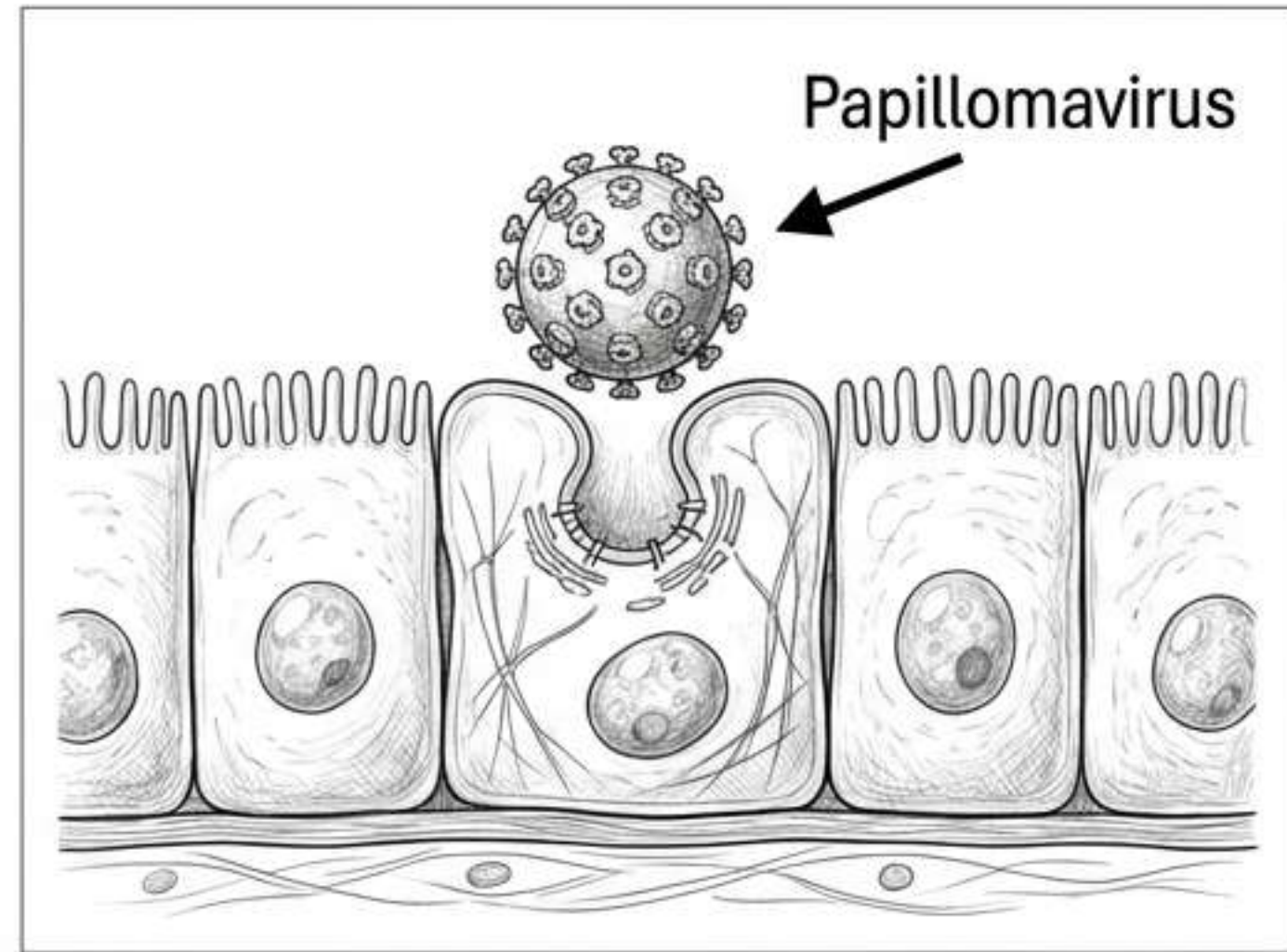
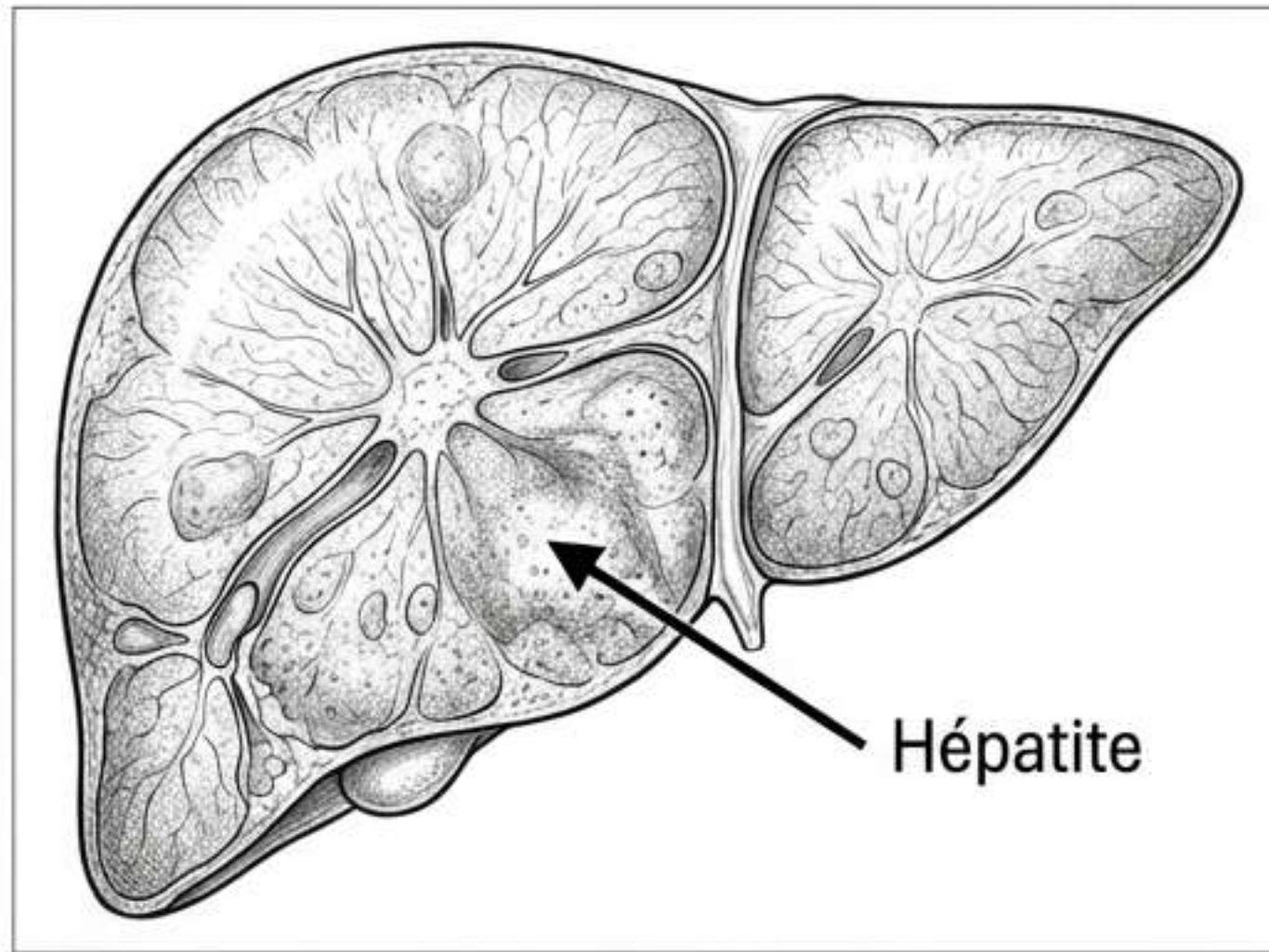


Virus des hépatites B et C et Papillomavirus

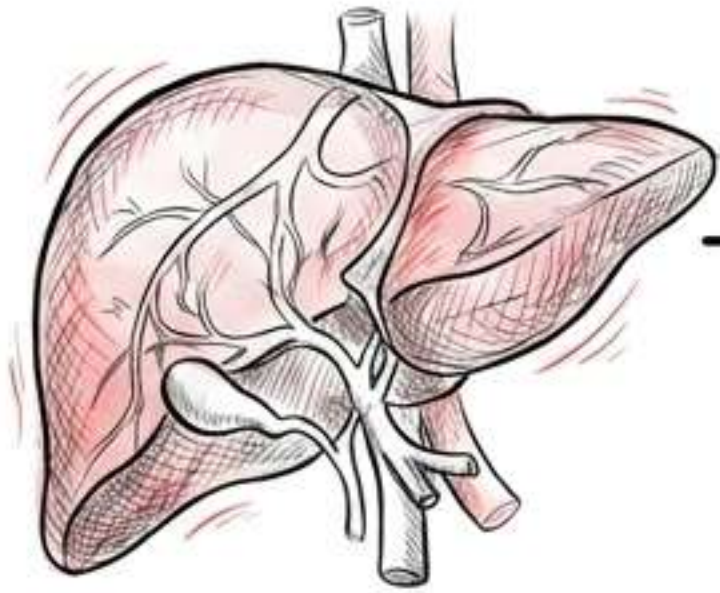
Cours de médecine dentaire



Dr Aicha BENSALAM
FACULTE DE MÉDECINE D'ALGER
Année universitaire 2024-2025

Définition de l'hépatite virale:

Atteinte inflammatoire du foie causée par des virus qui ont un tropisme hépatique dominant.
5 virus existent: de A à E.



Asymptomatique
(Majorité des cas)

Symptomatique

Clinique

Ictère, asthénie, troubles digestifs, syndrome grippal.

Biologie - Perturbation du bilan hépatique



Cytolyse hépatique: ↑ ALAT/ASAT
+/- cholestase: ↑ PAL et Bilirubine.

Étiologies des Hépatites

médicaments

Alcool

Bactérie

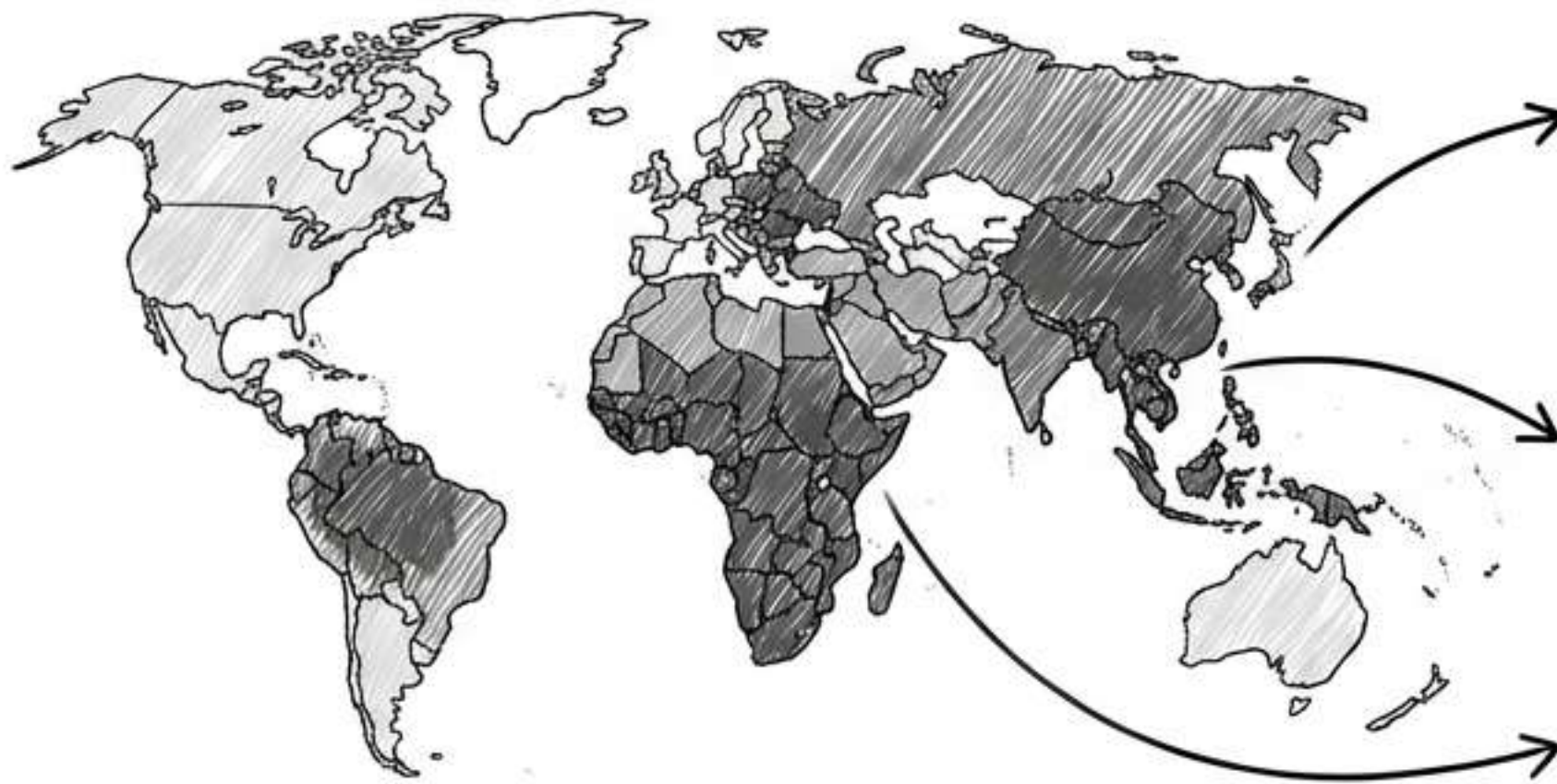
Virus
(HAV, HBV, HCV, HDV, HEV)

Auto
immune

[Ref: Q7]

[Predicted - Essential biological
diagnostic criteria]

GÉNÉRALITÉS VHB & ÉPIDÉMIOLOGIE



Forte (5-10%) :
Afrique subsaharienne,
Asie, bassin amazonien,
Europe orientale/centrale.

Intermédiaire (2-5%) :
Moyen-Orient, sous-continent indien,
Pays du Maghreb (Algérie 2,15% en 1998).

Faible (< 1%) :
Europe occidentale, Amérique du Nord.

Chiffres OMS 2019 :
296 millions de chroniques ;
1,5M nouvelles infections/an ;
820 000 décès
(cirrhose/carcinome).



Infection

(A)

Forme aiguë → asymptomatique +++
90% → Guérison

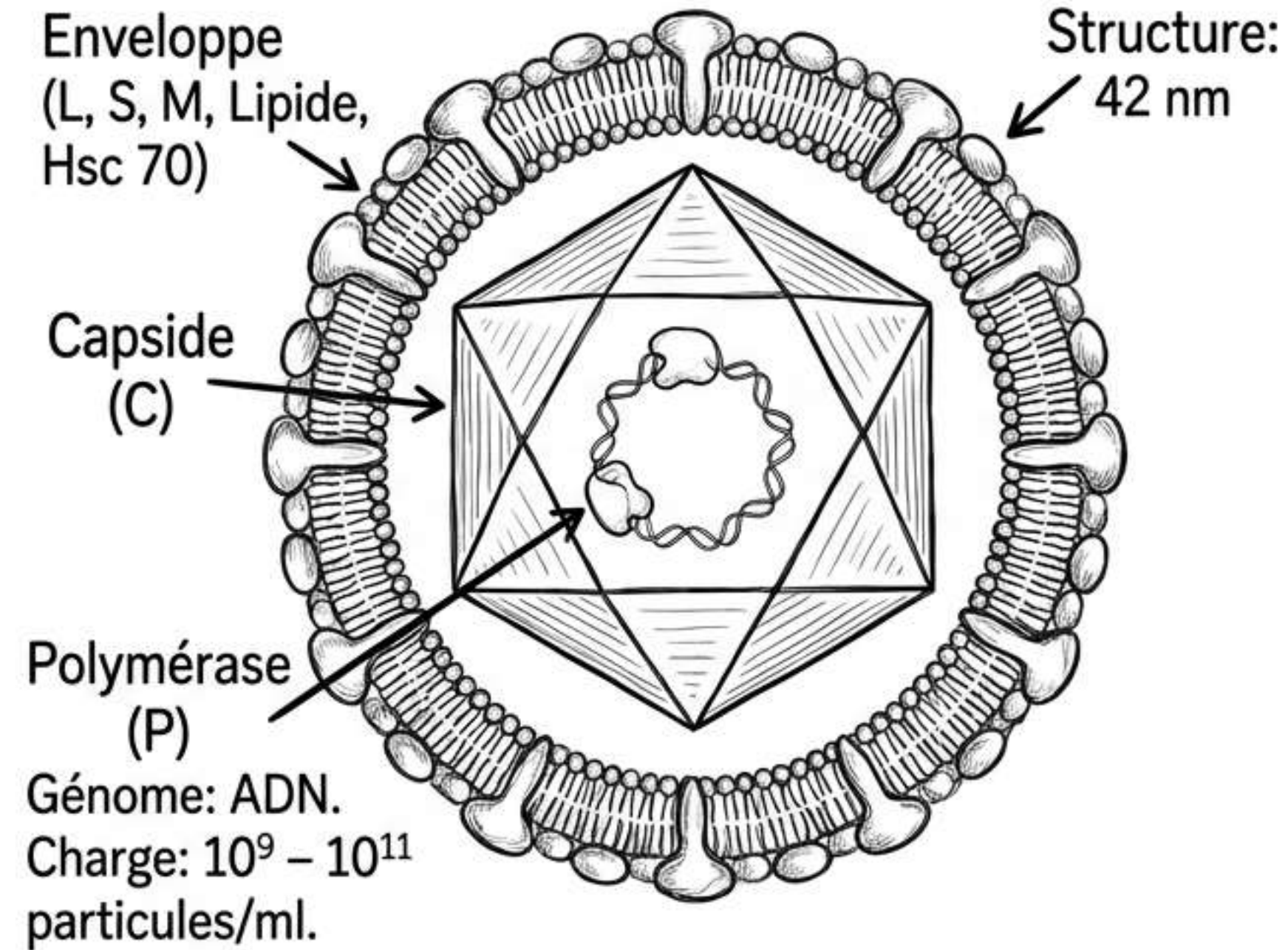
(B)

Persistance > 6 mois = Forme Chronique

Forme chronique : 90% - 95% Enfant / 5% - 10% Adulte [Ref : Q8]

VHB: Virologie & Modes de Transmission

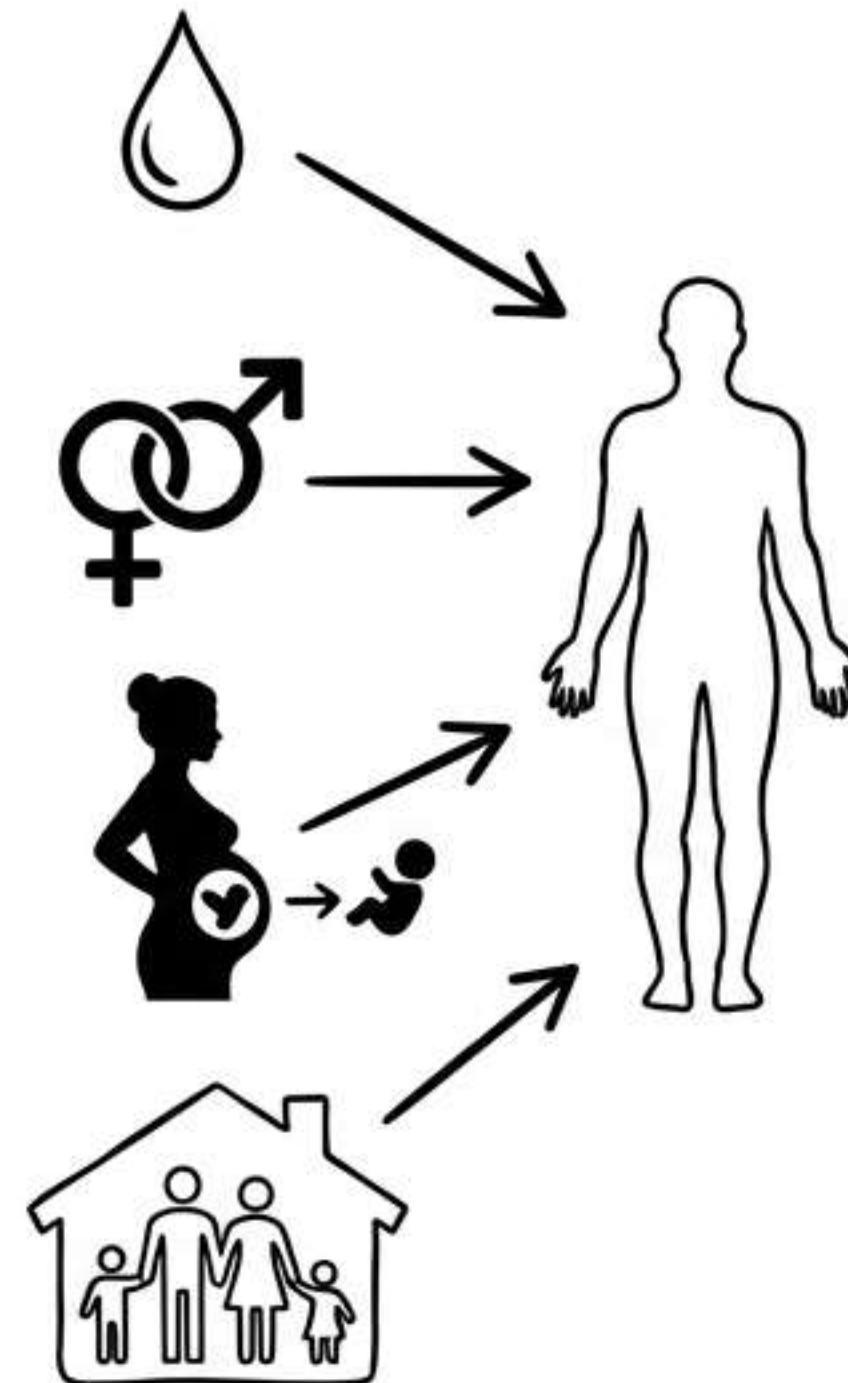
Virologie Structurale



Réplication dans le noyau (intégration ADN cellulaire)

→ formation du cccDNA (ADN super-enroulé) [Predicted - Deep virology target]

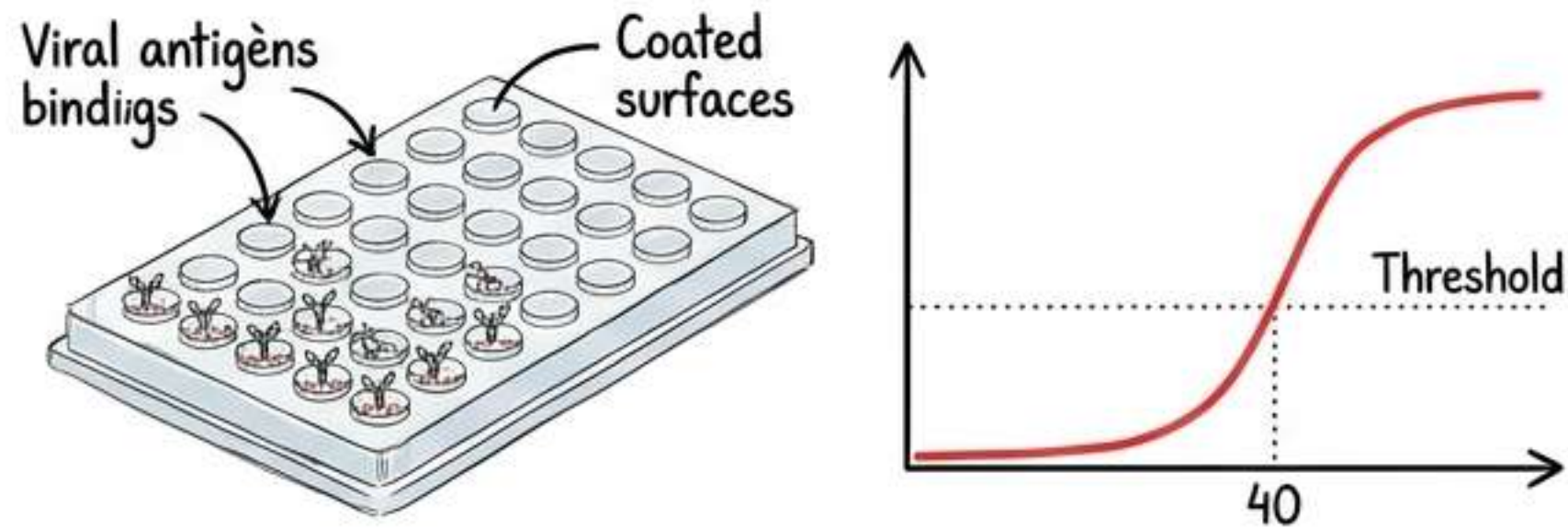
Modes de Transmission



Voie sanguine
(Transfusion, nosocomiale:
AES/dentiste,
Toxicomanie IV/IN).
Voie sexuelle (IST).
Voie verticale
(mère-enfant, 90% H.
chronique).
Voie horizontale
(intrafamiliale).
Inconnu.
PAS de voie féco-orale.
↪ Ref: Q4. [Ref: Q4]

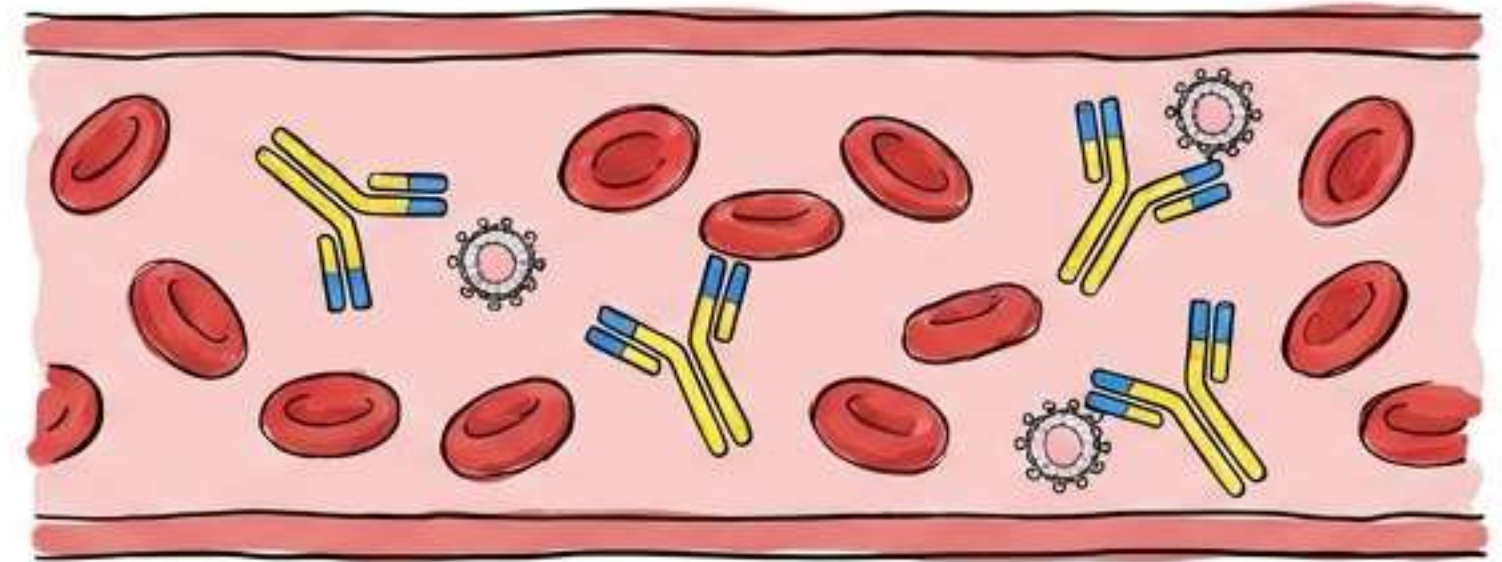
VHB : Diagnostic Direct (Virologique) vs Indirect (Sérologique)

Diagnostic Direct (Virologique)



- Technique EIA : Détection protéines virales.
- AgHBs : Marqueur de l'infection.
- AgHBe : Marqueur de réplication du virus sauvage.
- AgHBc : antigène de capside, intra hépatocytaire, jamais recherché [Predicted - Clinical trap]
- Biologie Moléculaire (PCR temps réel) : Détection génome (ADN-VHB) = charge virale. Suivi sous traitement.

Diagnostic Indirect (Sérologique - Anticorps)



- Ac anti-HBc IgM : Infection aiguë.
- Ac anti-HBc IgG : Cicatrice sérologique.
- Ac anti-HBe : Arrêt de la réplication.
- Ac anti-HBs : immunisation (vaccination ≥ 10 mUI/ml) [Ref: Q10]

VHB - Interprétations Sérologiques



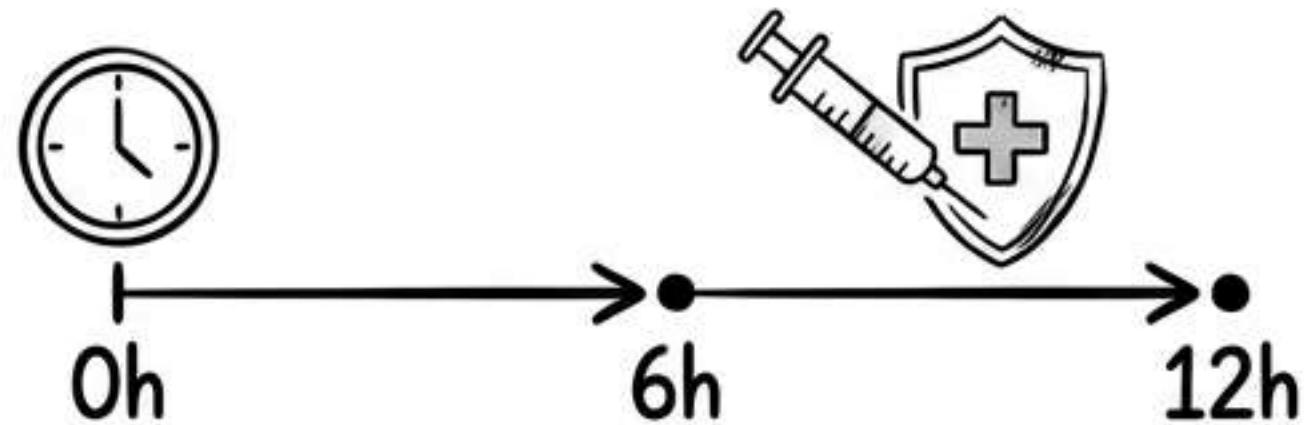
Marqueurs (Ag/Ac)	Profil	Interprétation
Négatif partout	Vierge	Absence de contact avec le VHB
Seul Ac anti-HBs Positif (≥ 10 mUI/ml)	Vacciné	Sujet vacciné
Ac anti-HBc IgG (+) & Ac anti-HBs (+)	Guéri	Infection résolue (guérison)
AgHBs (+) & Ac anti-HBc IgM (+)	Aigu	Infection aiguë en cours
AgHBs (+) & Ac anti-HBc IgG (+)	Chronique	Infection chronique en cours

Pièges & Situations Particulières (Ac anti-HBc isolés)

- Infection ancienne +++
- Réponse anamnestic: Apparition Ac anti-HBs après rappel
- Fenêtre sérologique lors de l'infection aiguë: IgM HBc ou 2ème prélèvement après un mois. [Predicted - Advanced clinical reasoning]
- Hépatite occulte: Faire la charge virale (ADN-VHB)
- Co-infections: VHB-VHC, VHC-VHD, VHC-VIH

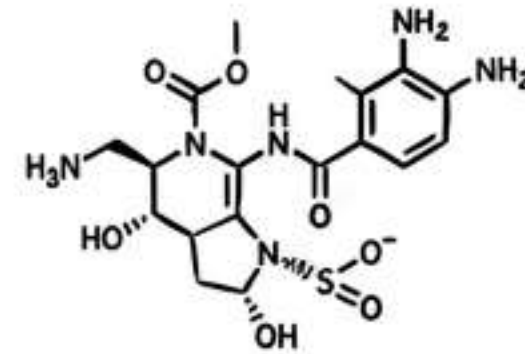
VHB: Prévention & Traitement

Prévention VHB



- PEV Algérie depuis 2003.
- Femme enceinte séropositive: Sérovaccination des nouveaux nés dans les 6 à 12 h (Gammaglobuline spécifique + Vaccin Anti-HBV).
- Populations à risque: Personnel médical, conjoint positif (vacciner entourage).
- Le praticien n'a pas le droit de refuser des soins; précautions universelles.

Traitement (Algérie)

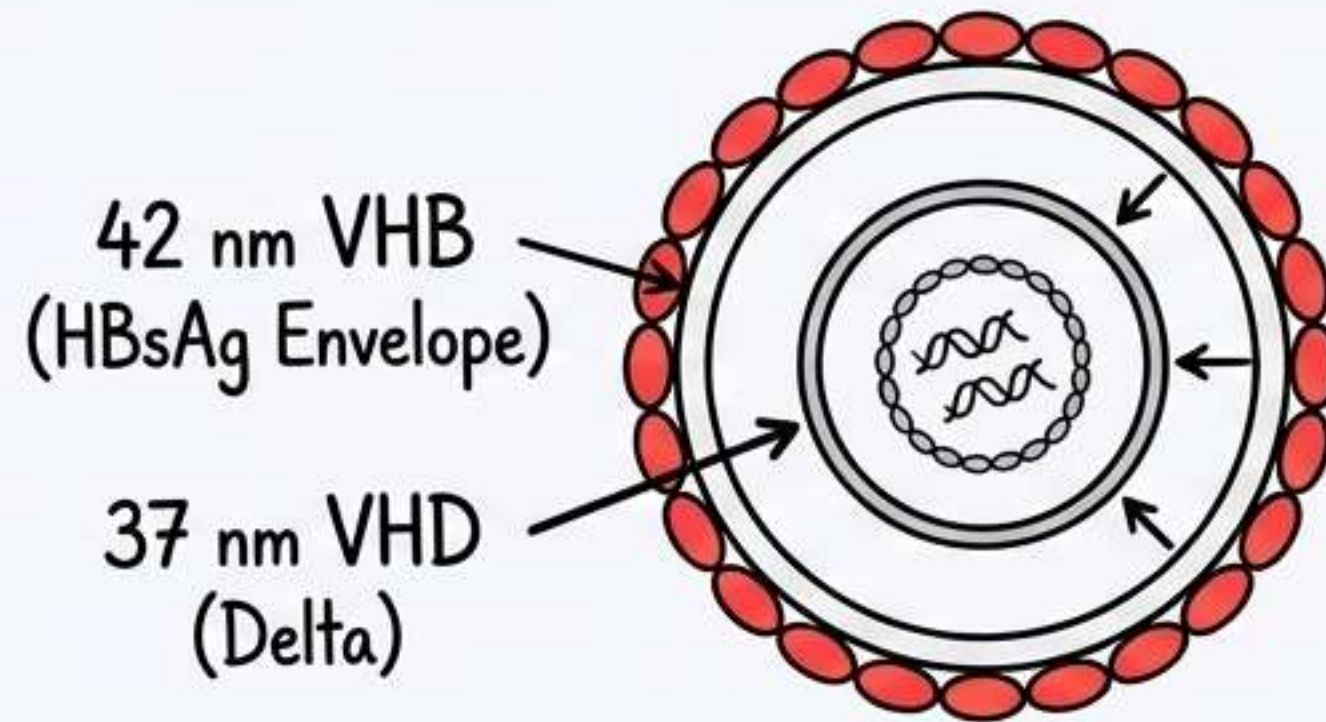


Interféron:
Pégylé ou Standard



- Inhibiteurs nucléo(s)tidiques:
entecavir, tenofovir
[Predicted
- Pharmacological
specifics]

Dossier VHD (Delta) - Le Virus Satellite



VHD (Delta) hijacks AgHBs envelope

Coïnfection (simultanée)
→ Formes fulminantes

Surinfection (séquentielle)
→ Hépatite sévère

Transmission & Diagnostic

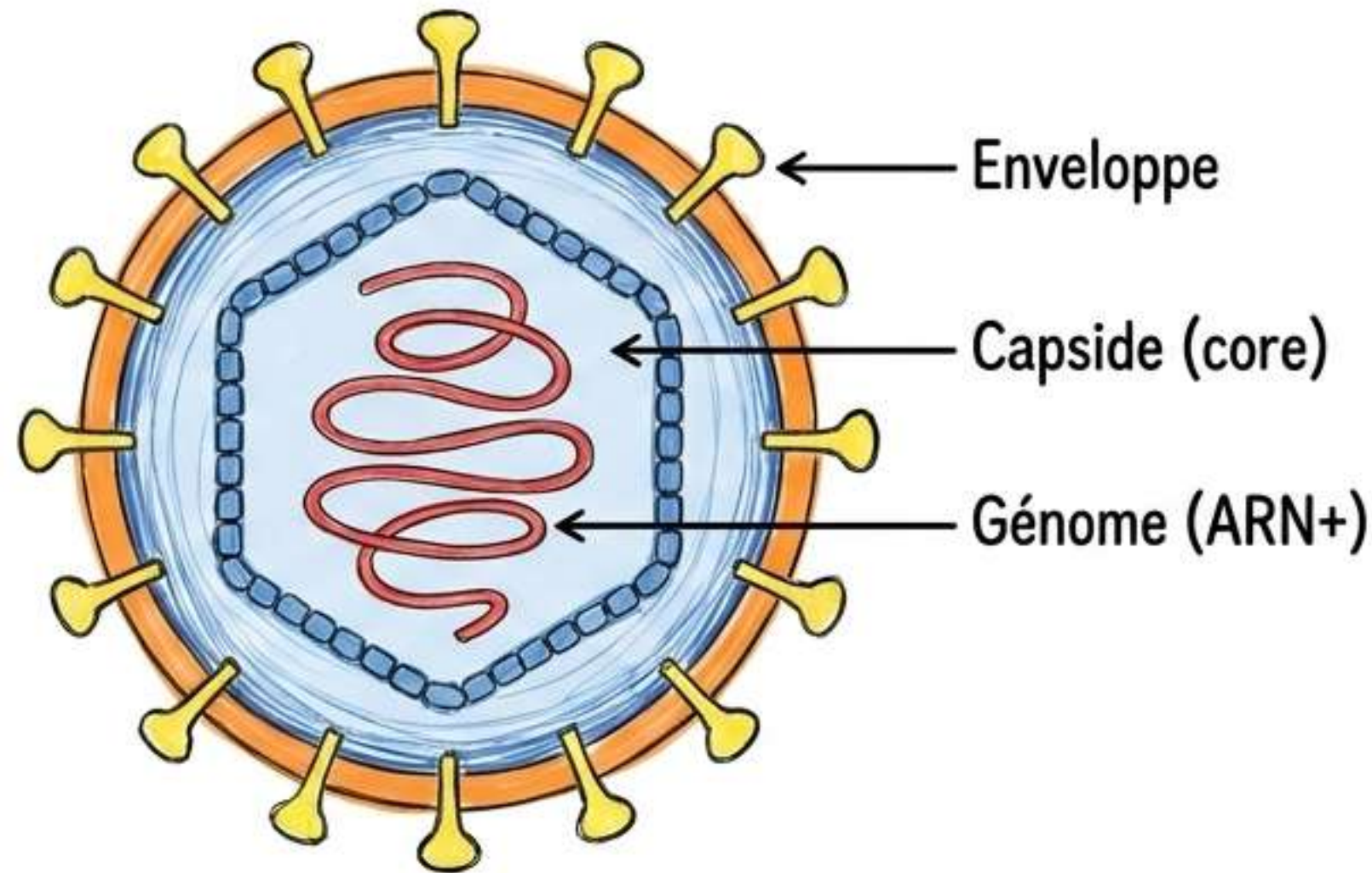
- Transmission : Identique au VHB (sanguine, sexuelle, verticale).
- Indirect : ELISA IgG/IgM anti-VHD (IgM persiste si chronique).
- Direct : ARN du VHD.

- L' antigène VHD : très fugace, non recherché [Predicted - Diagnostic exception]

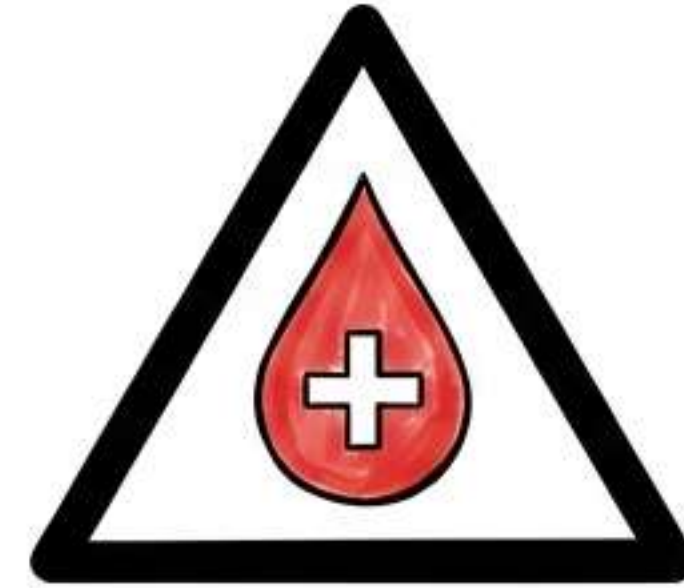
Traitement & Prévention

- Traitement lourd et décevant.
- La prévention repose exclusivement sur la vaccination contre l'hépatite B [Ref: Q5]

Dossier VHC - Épidémiologie & Virologie



- Famille: Flaviviridae. Genre: Hepacivirus.
- Évolution majoritaire vers la chronicité sans traitement.
- 58M porteurs chroniques, 1,5M nouvelles infections/an.
- 3,2M adolescents/enfants atteints. [Predicted - High yield pediatric stat]



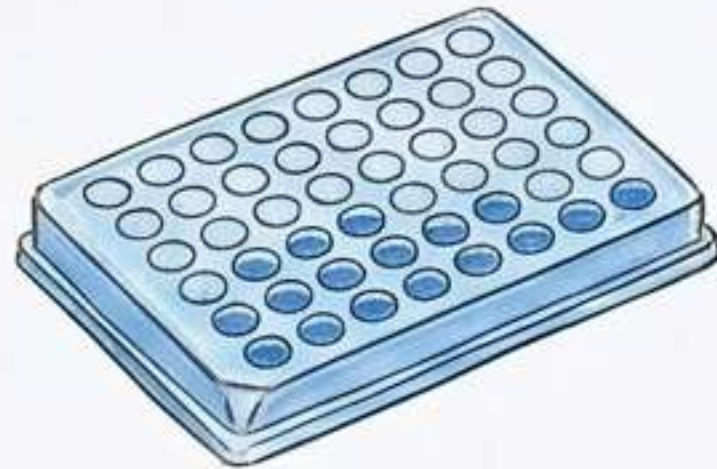
Modes de Transmission VHC:

- Voie Sanguine dominante (parentérale):
Transfusion/greffe avant 1994, Toxicomanie,
Hémodialyse, Endoscopie, Tatouage/piercing/hidjama,
Soins dentaires, AES professionnels.

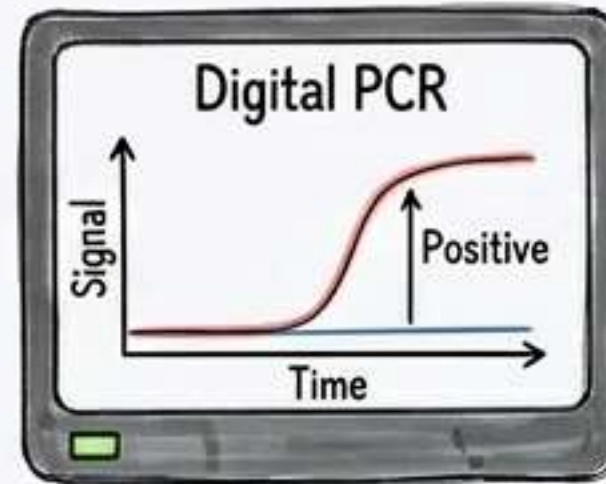
[Ref: Q2, Q6]

- Transmission mère-enfant: 3 à 5%
(sauf co-infection VIH = 20%).
- Circonstance inconnue: 20%.

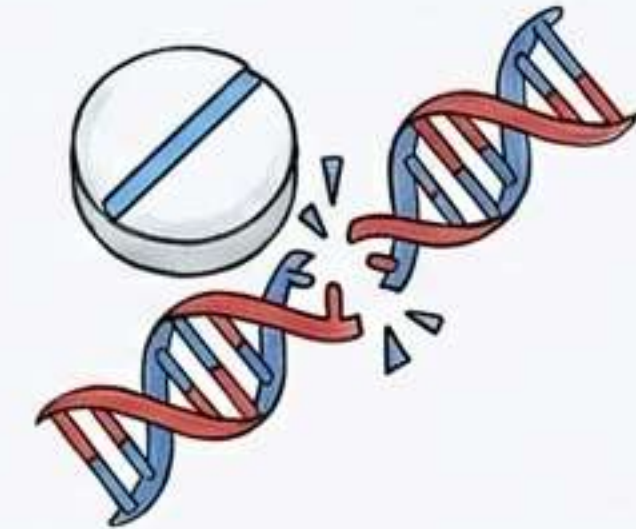
VHC - Diagnostic, Traitement & Prévention



Dépistage



Confirmation



Guérison

Diagnostic VHC

- Indirect (Sérologique): Dépistage par ELISA, présence Ac anti-VHC = signe un contact (ne pose pas le diagnostic positif d'infection) [Ref: Q3]
- Direct (Virologique): PCR temps réel (ARN-VHC) = diagnostic de l'infectiosité.

Prévention

- Règles générales d'hygiène, stérilisation des outils (dentaire, hidjama).
- Il n'existe pas de vaccin à ce jour [Ref: Q6, Q9]

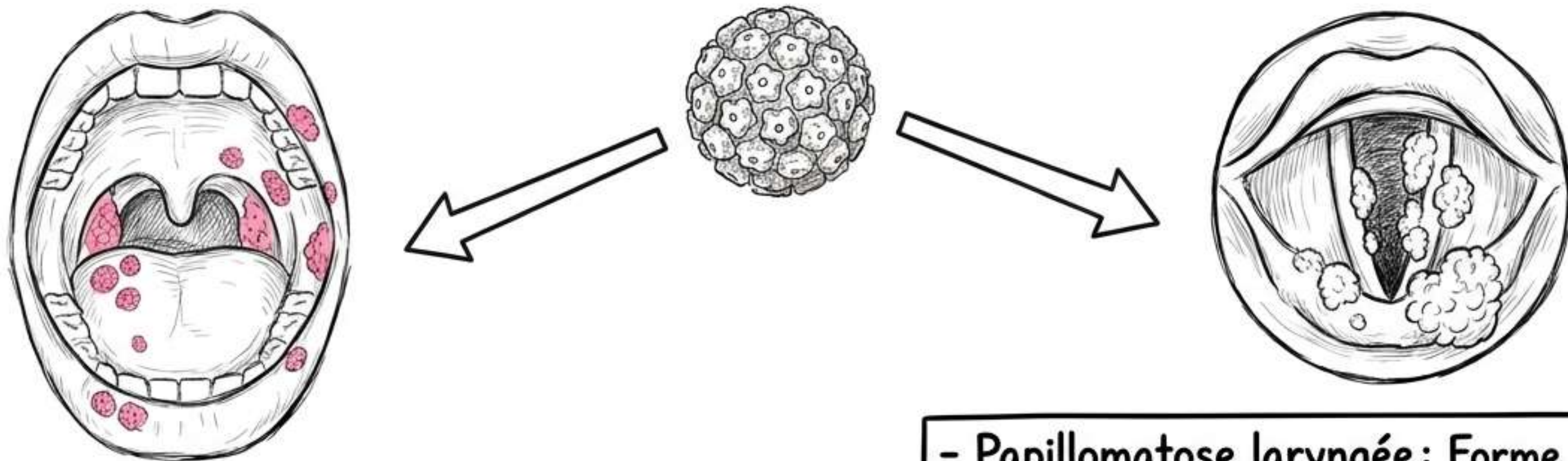
Traitement Révolutionnaire

- Curable par les Antiviraux à Action Directe (AAD) aboutissant à l'élimination du VHC [Ref: Q1]
- Molécules en Algérie: Sofosbuvir-Daclatasvir (pangénotypique) [Predicted - Specific pharmacology target]

Matrice de Synthèse: VHB vs VHD vs VHC

	VHB	VHD	VHC
Famille / Génome	ADN, 42nm	ARN, 37nm (Satellite)	Flaviviridae, ARN+
Transmission Dominante	Sanguine, sexuelle, verticale	Sanguine, sexuelle, verticale	Sanguine massive
Taux Chronicité (Adulte)	5 à 10%	Très élevé (Surinfection)	Majorité des cas
Dépistage Indirect	Ac anti-HBc, anti-HBs	Ac anti-VHD	Ac anti-VHC
Marqueur Direct	ADN-VHB (PCR)	ARN-VHD (PCR)	ARN-VHC (PCR)
Vaccin Disponible	OUI (Recombinant)	OUI (Vaccin VHB)	NON
Traitement Curatif	Entecavir, Tenofovir, IFN	Décevant / Lourd	OUI (AAD: Sofosbuvir)

Dossier HPV - Généralités & Pathologies Bénignes



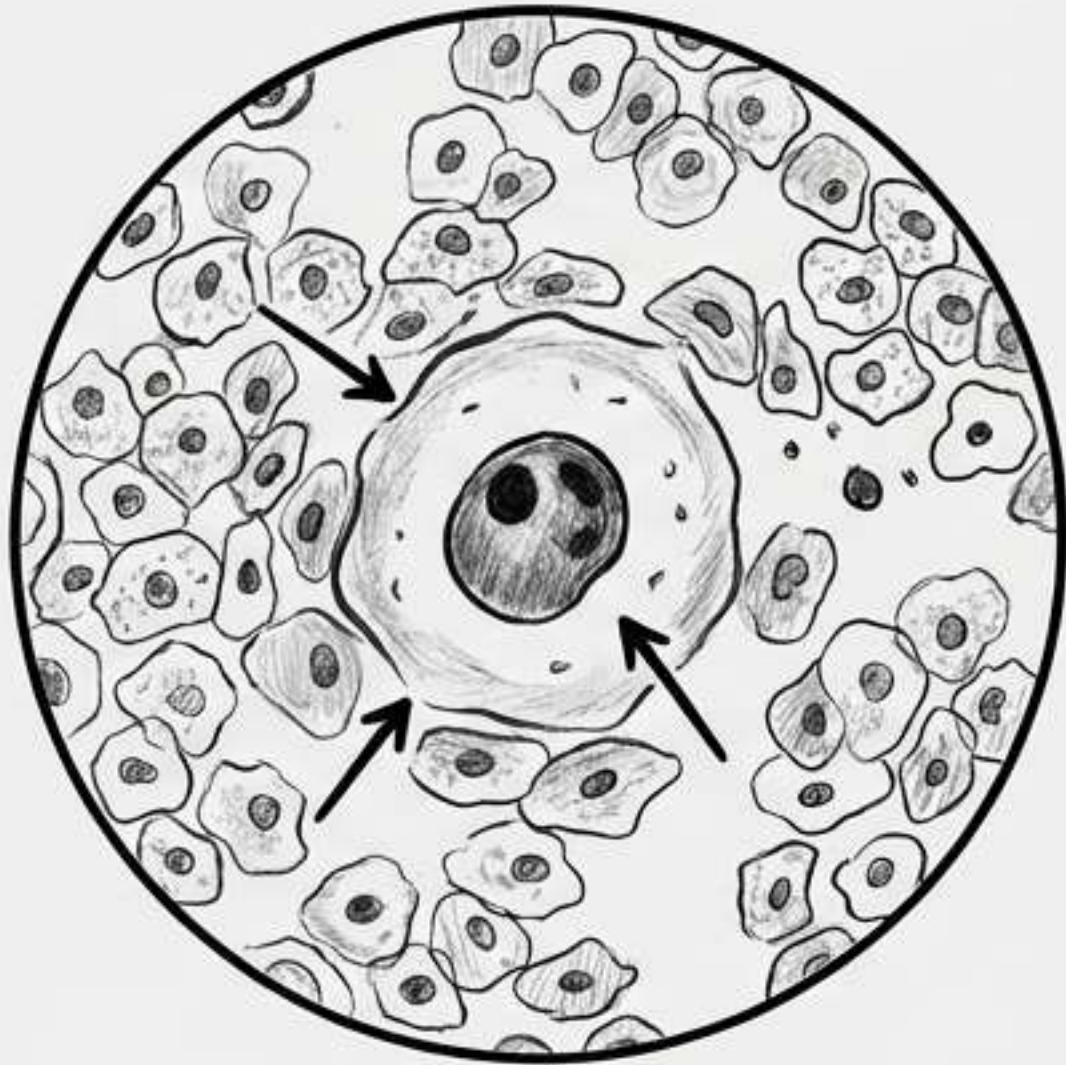
Lésions Bénignes ORL (Bas risque: HPV 6 et 11)

- Papillomes cavité buccale/oropharynx: Aspect framboisé, souple, asymptomatique.
Traitement: Exérèse chirurgicale.

- Papillomatose laryngée: Forme juvénile (1^{ère} cause tumeur bénigne enfant).
Dysphonie, risque d'obstruction.
- Traitement: Chirurgical + **Injection locale de cidofovir dans les formes multi-récurrentes**
[Predicted - Specific ENT treatment protocol]

Généralités Papillomaviridae: Tropisme pour épithéliums malpighiens et muqueuses.
Transmission: Sexuelle (génitale/orale), cutanée, verticale, surfaces.

Dossier HPV - Cancers, Diagnostic & Prévention



- Cytologie: Recherche de koilocytes (cellules caractéristiques) sur frottis cervico-vaginal ou anal. [Predicted - Gold standard cellular marker]
- Diagnostic virologique direct: PCR pour génome viral.



Carcinome épidermoïde (Oncogènes haut risque: HPV 16 et 18)

- 25% des cancers ORL.
- Oropharynx = localisation principale (35-40%).
- Les hommes sont principalement atteints (78%). [Predicted - Demographic statistic trap]
- Prévention: Vaccination. Couvre HPV 6, 11, 16, 18. Préviend infection et cancer du col.

Analyse des Tendances d'Examen (Exam Pattern Analysis)

Cibles Fréquentes (High Yield)



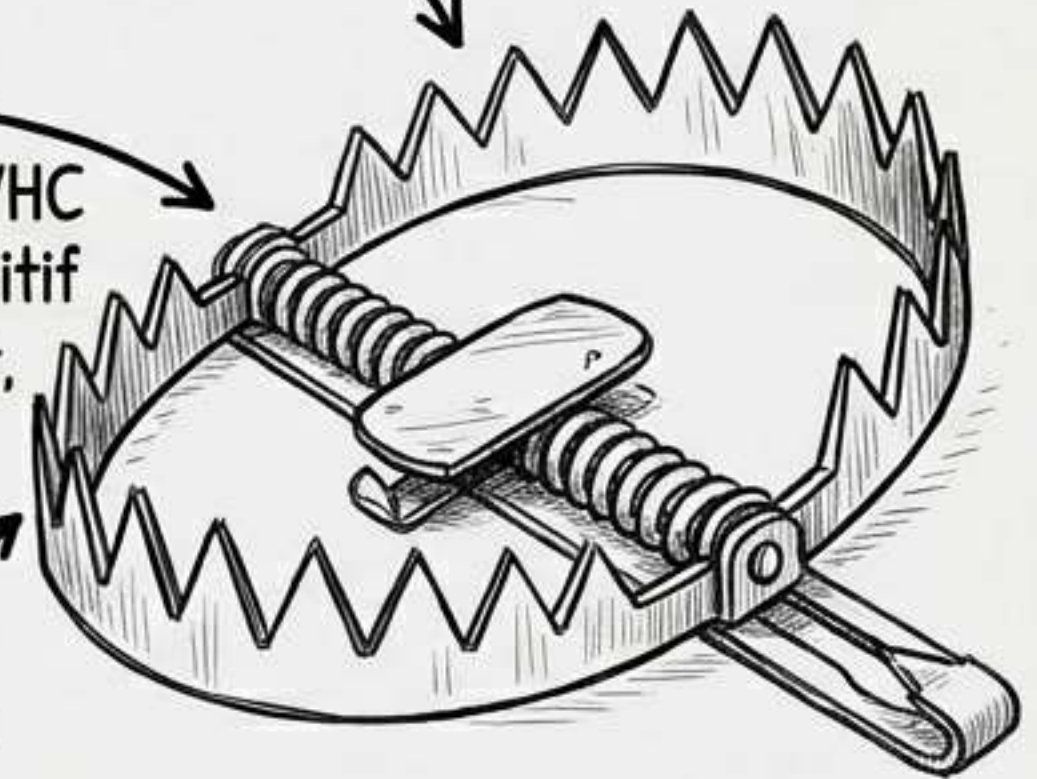
- Distinction absolue des modes de transmission (VHB vs VHC vs VHA/E).
- Absence de vaccin pour le VHC.
- Ac anti-HBs comme UNIQUE marqueur de réussite vaccinale.
- Efficacité curatrice des AAD (Sofosbuvir) pour le VHC.

Pièges Cliniques (High Risk)

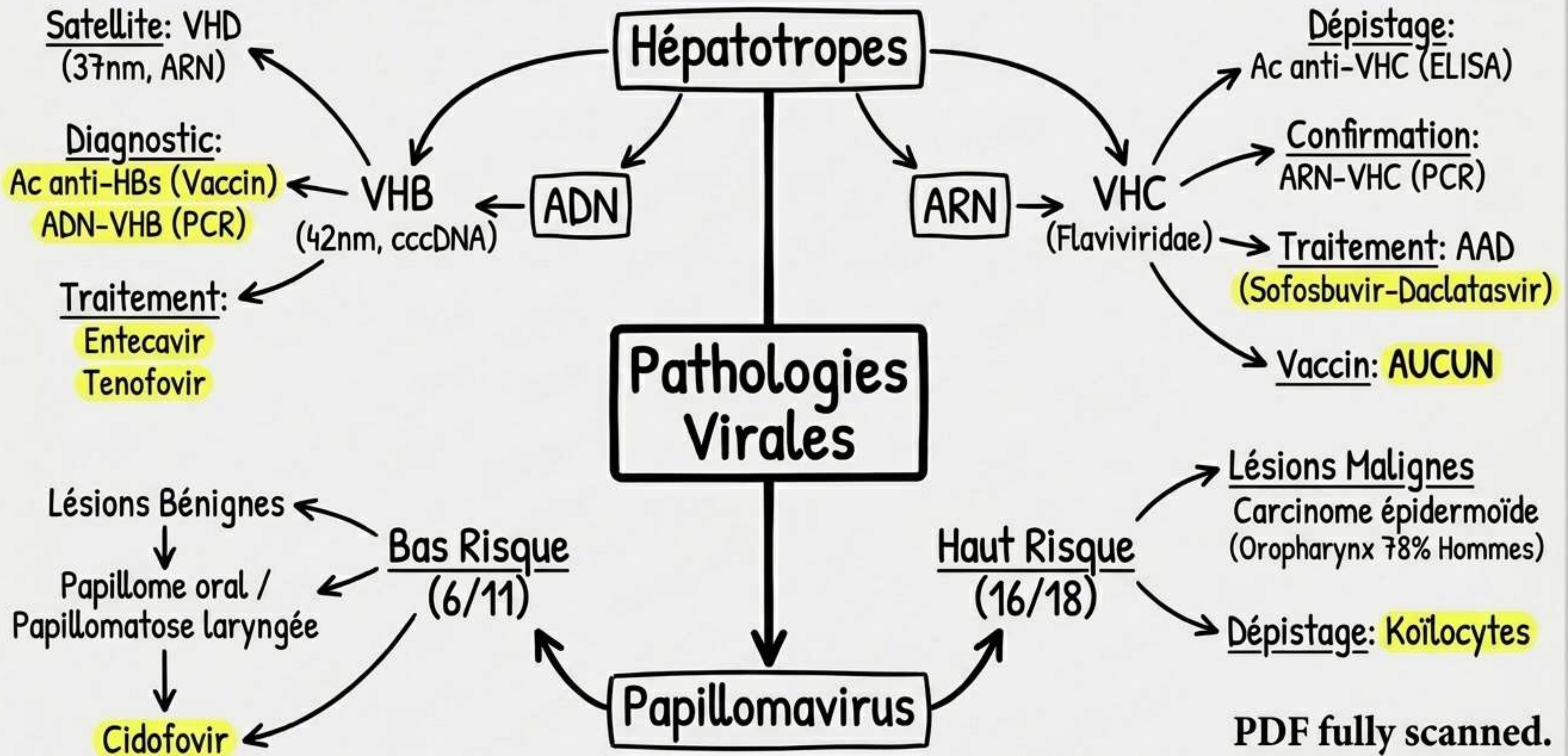
- Piège Chronique: Inverser les taux de chronicité VHB (Enfant = 90-95%, Adulte = 5-10%).

- Piège Dépistage: Croire que l'Ac anti-VHC pose le diagnostic positif (indique juste le contact, PCR requise).

- Piège Protecteur: Oublier que le vaccin VHB protège d'office contre le VHD.



Indice de Confiance Prédictive: Forte probabilité sur la pharmacologie (Cidofovir, Entecavir) et les marqueurs cytologiques HPV (Koïlocytes).



PDF fully scanned.
100% content coverage confirmed.
No omission detected.